

Répertoire MMed3 2019

Prof. J.-N. Despland

Tr. humeur

Quel est la fourchette de prévalence sur la vie de l'épisode dépressif majeur chez l'homme (sexe masculin)?

- A. 4-8%
- ☒ B. 8-12%
- C. 12-16%
- D. 16-20%
- E. >20%

Tr. humeur

Concernant les troubles de l'humeur, laquelle de ces propositions est **fausse** ?

- A. La transmission génétique joue un rôle plus élevé dans les troubles unipolaires que bipolaires
- B. La prévalence des troubles bipolaires est moins élevée que celle du trouble unipolaire
- C. Des troubles anxieux tels que des attaques de panique sont des comorbidités fréquentes des troubles bipolaires
- D. L'abus de substances psychotropes est une comorbidité fréquente des troubles bipolaires associée à un risque suicidaire augmenté
- E. Les thymorégulateurs représentent la base du traitement pharmacologique des troubles bipolaires

Tr. humeur

Parmi ces facteurs de risque, quel est celui qui est **le moins spécifique** de la dépression postnatale ?

- A. Anamnèse de dépression(s) antérieure(s)
- B. Relation conjugale conflictuelle
- C. Manque de soutien social
- D. Environnement difficile (facteurs de stress)
- E. Trouble de la personnalité

Tr. humeur

Vous constatez chez votre patient des épisodes dépressifs modérés et sévères alternant avec des épisodes hypomaniaques. Quel diagnostic retenez-vous ?

- A. Un trouble dysthymique
- B. Un trouble cyclothymique
- C. Un trouble bipolaire type I
- ☒ D. Un trouble bipolaire type II
- E. Un trouble schizoaffectif

Tr. humeur

Mme A. se plaint d'être de plus en plus mal depuis 4 semaines environ. Elle se sent fatiguée et n'a plus de plaisir à effectuer son travail d'assistante médicale alors qu'habituellement elle se plaît bien dans cette activité. Elle a aussi de la peine à se concentrer. Elle a augmenté sa consommation de cigarettes car elle se sent très nerveuse. Elle a de la peine à s'endormir et se réveille tôt. Elle décrit aussi des bouffées d'angoisse survenant la nuit. Elle mange de moins bon appétit, mais n'a pas perdu de poids. Elle pense ne pas avoir de problème particulier sur le plan familial, social ou professionnel. L'observation clinique et les examens de laboratoire sont dans la norme.

Question 1 : Quels sont les symptômes de cette patiente qui sont compatibles avec un Episode dépressif majeur ?

Question 2 : Quelles sont les autres symptômes ou signes spécifiques d'un Episode dépressif majeur que vous devez rechercher ?

Tr. humeur

Une jeune femme de 26 ans vous consulte le 10 octobre en raison de la survenue récurrente fois d'un épisode dépressif majeur survenant à la même période de l'année. Elle n'a pas d'idée suicidaire, ni de symptôme psychotique. Elle signale qu'elle a pris l'habitude de partir pour les vacances de Noël aux Maldives elle s'y sent mieux. Quelle est l'attitude la plus pertinente ?

- A. La faire revenir dans une semaine pour contrôler l'évolution de son état
- ☒ B. Lui prescrire un traitement d'essai de luminothérapie
- C. Lui prescrire un traitement antidépresseur
- D. Lui prescrire une psychothérapie
- E. Lui proposer un traitement antidépresseur et une psychothérapie (traitement combiné)

Tr. humeur

Un patient de 40 ans se rend à la consultation d'un médecin généraliste car il se sent soudainement fatigué, sans énergie. Ralenti et peu communicatif, il raconte répétitivement qu'il se serait récemment endetté et aurait trompé son épouse. Il se sent très coupable et pense au suicide. Quelle est la prochaine mesure à prendre ?

- A. Hospitalisation en hôpital psychiatrique
- ☒ B. Investigation du risque suicidaire
- C. Prescription d'une benzodiazépine
- D. Contrat de non-suicide
- E. Appeler l'épouse

Tr. humeur

Madame A. est une jeune patiente de 26 ans, qui est en 5^{ème} année de médecine. Elle consulte son médecin généraliste en raison d'un épisode dépressif d'intensité moyenne sans symptômes psychotiques (7 critères sur les 9 pour l'Episode dépressif majeur), qui a débuté 1 mois auparavant, suite à une rupture amoureuse. Elle n'a pas d'idées suicidaires. Elle n'a pas d'antécédents psychiatriques. Elle décrit des relations familiales assez froides et distantes et signale que ses parents sont en train de divorcer. Quelle est l'attitude la plus pertinente?

- A. La rassurer sur le fait que sa réaction est compréhensible et adéquate et lui dire de téléphoner si les symptômes persistent
- B. Souligner qu'elle est déprimée et lui proposer un deuxième entretien dans une semaine pour faire le point
- C. Débuter un traitement antidépresseur (SSRI)
- D. Lui proposer un consilium psychiatrique pour évaluer la pertinence d'une psychothérapie
- E. Lui proposer de la voir avec ses parents

Tr. humeur

Vous recevez à votre consultation une jeune femme de 22 ans, étudiante en HEC, qui se plaint de difficultés familiales et sentimentales. Vous l'aviez déjà reçue à deux reprises, la première fois pour un épisode dépressif après une rupture sentimentale, qui s'était spontanément résolu, et la deuxième suite à un passage aux urgences du CHUV pour une alcoolisation massive et des idées suicidaires peu scénarisées. Elle décrit des réactions de colère inappropriées, des épisodes de boulimie peu spécifiques, une tendance à s'alcooliser fortement les week end, ainsi qu'une difficulté à savoir ce qu'elle se veut. La description qu'elle fait d'elle-même est oscille entre des images dévalorisées et une confiance parfois excessive dans ses avis. Ce mode de fonctionnement semble présent de manière stable depuis qu'elle a 16 ans. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Trouble dysthymique
- B. Trouble de l'adaptation avec humeur mixte et trouble du comportement
- C. Trouble dépressif majeur récurrent, avec des abus d'alcool
- D. Trouble bipolaire de type 2
- E. Trouble de la personnalité borderline

Tr. humeur

Une patiente de 23 ans, d'apparence soignée, consulte en urgence son médecin généraliste pour une symptomatologie dépressive. Elle se met à pleurer immédiatement et explique qu'elle se sent mal depuis quelques jours, suite à des conflits répétés avec son chef qu'elle trouve trop exigeant. Sans avertir son patron, elle n'est pas retournée au travail parce qu'elle se sent trop angoissée et déprimée et affirme sur un ton désespéré ne plus pouvoir y retourner. Parmi les attitudes ci-dessous, laquelle est la moins pertinente ?

- A. Vous faites un arrêt de travail d'une semaine et lui proposez de prendre contact avec son patron pendant ce temps-là
- B. Vous lui dites qu'elle est déprimée et vous lui prescrivez un antidépresseur de type SSRI**
- C. Vous suspendez toute décision et lui proposez un nouveau rendez-vous pour rediscuter plus en détail de tout cela dans 2 jours
- D. Vous expliquez qu'il n'est pas possible de faire un certificat rétroactif et lui proposez de prendre contact rapidement avec son patron
- E. Vous lui proposez de prendre contact avec son patron et de la revoir rapidement pour l'aider

Tr. humeur

Une semaine après l'introduction de la sertraline (un inhibiteur de la recapture de la sérotonine) chez une patiente pour un épisode dépressif majeur, celle-ci se plaint qu'il n'y a aucune amélioration, et que ses insomnies se sont même péjorées. Quelle stratégie vous semble **la plus adéquate** ?

- A. Ne rien changer, rappeler à la patiente que la réponse au traitement va prendre du temps (2 à 3 semaines après le début du traitement)
- B. Ne rien changer, rappeler à la patiente que la réponse au traitement va prendre du temps (4 à 8 semaines après le début du traitement)
- C. Remplacer la sertraline par un antidépresseur tricyclique sédatif
- ☒ D. Rappeler à la patiente que la réponse au traitement va prendre du temps (2 à 4 semaines après le début du traitement), et prescrire pour la plus courte période possible un sédatif (benzodiazépine ou apparenté)
- E. Rappeler à la patiente que la réponse au traitement va prendre du temps (4 à 8 semaines après le début du traitement), et prescrire pour la plus courte période possible un sédatif (benzodiazépine ou apparenté)

Tr. humeur

Chez un patient recevant un traitement par un antidépresseur pour un premier épisode dépressif, quelle devrait être la durée du traitement?

- A. Au minimum 6 mois après que le patient ait commencé à répondre au traitement
- B. Au minimum 3 mois après la rémission
- ☒ C. Au minimum 6 mois après la rémission
- D. Au minimum 1 an après le début de l'épisode dépressif
- E. Au minimum 1 année après la rémission

Tr. humeur

Une femme de 25 ans a été hospitalisée suite à une tentative de suicide. Cette femme a déclaré qu'elle pleurait souvent pendant les deux derniers mois et qu'elle a commencé depuis lors à se désintéresser de ses amis et des activités sociales. Elle déclare aussi avoir d'importants troubles du sommeil. C'est un premier épisode. Quel serait le traitement pharmacologique le plus adéquat parmi ceux proposés ci-dessous?

- A. Benzodiazépine
- B. Neuroleptique sédatif
- C. Antidépresseur tricyclique sédatif
- ☒ D. Antidépresseur du type inhibiteur de la recapture de la sérotonine et benzodiazépine
- E. Stabilisateur de l'humeur et une benzodiazépine

Tr. humeur

Chez un patient ne répondant pas à un traitement antidépresseur (inhibiteur de la recapture de la sérotonine), une combinaison de deux médicaments est prévue, pour tenter d'augmenter la réponse antidépressive. Laquelle de ces combinaisons est à éviter absolument car pouvant augmenter de façon importante le risque d'un syndrome sérotoninergique?

- A. Citalopram et venlafaxine, un inhibiteur de la recapture de la noradrénaline et de la sérotonine
- B. Citalopram et moclobémide, un inhibiteur de la monoamine oxydase**
- C. Citalopram et lithium, un stabilisateur de l'humeur
- D. Citalopram et quetiapine, un antipsychotique
- E. Citalopram et mirtazapine, un antidépresseur sérotoninergique et noradrénergique

Tr. humeur

Lors de l'arrêt d'un traitement antidépresseur avec un inhibiteur de la recapture de la sérotonine ou un inhibiteur de la recapture de la sérotonine et noradrénaline, il est recommandé si possible de baisser progressivement la dose de l'antidépresseur sur quelques semaines. Pour quelle raison ?

- A. Pour éviter un effet rebond de la dépression
- ☒ B. Pour éviter un syndrome de sevrage sérotoninergique
- C. Pour éviter le risque de dépendance
- D. Pour ne pas inquiéter le patient par un arrêt trop brusque de la prescription
- E. Aucune des raisons ci-dessus

Tr. humeur

Vous recevez dans votre cabinet une jeune patiente de 30 ans, sans antécédents. Elle vous décrit une rupture sentimentale difficile il y a une semaine. Elle évoque souffrir depuis d'une tristesse accompagnée de pleurs, de ruminations anxieuses, d'aboulie, d'anhédonie, de troubles du sommeil et de l'appétit. La patiente, angoissée, vous demande un traitement. A l'issue de votre entretien, vous fixez un nouveau rendez-vous dans une semaine et vous proposez :

- A. Un anxiolytique, type benzodiazépine.
- B. Un neuroleptique sédatif, tel que la quetiapine.
- C. Un antidépresseur, type tricyclique
- D. Un antidépresseur, type inhibiteur de la recapture de la sérotonine.
- E. Un stabilisateur de l'humeur, type lithium.

Tr. humeur

Un patient de 23 ans est traité par un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine pour son premier épisode dépressif. L'évolution est favorable et le patient relate, lors d'une consultation, que son énergie est revenue. Il sort beaucoup et il n'a presque plus besoin de dormir pendant la nuit. Quelle mesure thérapeutique immédiate est indiquée ?

- A. Arrêter l'antidépresseur
- B. Ajouter un stabilisateur de l'humeur à l'antidépresseur
- C. Remplacer l'antidépresseur par un stabilisateur de l'humeur
- D. Ajouter un neuroleptique à l'antidépresseur
- E. Remplacer l'antidépresseur par un neuroleptique classique

Tr. humeur

Un médecin généraliste est appelé auprès d'un patient de 28 ans, agité depuis quelques jours. Celui-ci l'accueille familièrement. Il dit qu'il l'a déjà rencontré et qu'il serait heureux de voir le médecin collaborer à la vaste campagne de promotion de la santé qu'il souhaite mettre en place. Il affirme avoir acheté ce jour une maison afin d'y implanter le siège social de son association ainsi que du matériel de bureautique et une voiture. Il a 3000 Frs en poche et souhaite sortir afin d'acheter des documents pour choisir les grandes orientations de son association. Sa famille dit qu'il ne dort plus depuis quelques jours, et que son comportement s'est rapidement modifié. Il était, il y a quelques semaines, plutôt calme et morose, réfléchissant beaucoup sur ce qu'il souhaitait faire de sa vie.

Quelles sont, parmi les classes médicamenteuses, celle qui risque d'être la plus efficace chez ce patient ?

- A. Antidépresseur sédatif
- B. Barbiturique
- ☒ C. Neuroleptique sédatif
- D. Benzodiazépine
- E. Régulateur de l'humeur

Tr. humeur

Laquelle des affirmations suivantes est correcte concernant le traitement d'un épisode dépressif ?

- A. La pharmacothérapie est plus efficace que la psychothérapie pour le traitement d'épisodes dépressifs de sévérité modérée
- B. Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine induisent souvent une prise de poids
- C. Les neuroleptiques sédatifs peuvent être indiqués pour calmer une dépression
- ☒ D. Le lithium peut potentialiser l'effet des antidépresseurs
- E. Un antidépresseur n'a pas d'effet préventif lorsqu'il est administré à long terme

Tr. humeur

La raison la plus importante de contrôler régulièrement les taux sanguins de lithium est:

- A. pour vérifier la compliance du patient
- ☒ B. parce que la dose toxique est proche de la dose thérapeutique
- C. parce que le lithium est rapidement excrété dans les urines
- D. parce que le lithium est un sel minéral
- E. aucune des raisons ci-dessus

Molécules courantes

Antipsychotique classique incisif : haloperidol

Antipsychotique classique sédatif : levomepromazine

Antipsychotique atypique : clozapine, risperidone, quetiapine

Antidépresseurs tricycliques (inh recapt séro / nora) : amitriptyline

Antidépresseur Inhibiteur sélectif recapture sérotonine : citalopram, sertraline

Antidépresseur Inhibiteur recapture sérotonine noradrénaline : venlafaxine

Antidépresseur sélectif sérotonine noradrénaline : mirtazapine

Mécanismes d'action des antidépresseurs

[illegible]

Tr. anxieux

Quel est le symptôme le plus spécifique d'un état anxieux par rapport à un état dépressif?

- A. Fatigue
- B. Troubles du sommeil
- C. Troubles de l'appétit
- D. Plaintes somatiques
- E. Vécu de dépersonnalisation

Tr. anxieux (K')

Un patient de 62 ans vous consulte pour des bouffées d'angoisse récurrentes depuis 3 semaines, dont certains symptômes lui font craindre de l'angine de poitrine ou un infarctus. Vous excluez de manière vraisemblable un trouble somatique et vous posez un diagnostic de trouble panique. Après lui avoir communiqué le résultat des investigations quelles sont les attitudes possibles que l'on peut considérer comme adéquate:

- A. Vous lui proposez de le revoir dans une semaine pour surveiller l'évolution de ses symptômes
- B. Vous lui prescrivez de l'alprazolam 0,25 mg en réserve, à prendre lorsqu'une bouffée d'angoisse survient
- C. Vous lui prescrivez de l'alprazolam 0,25 mg, 3x/jour
- D. Vous lui prescrivez 12 séances de thérapie cognitive et comportementale, qu'il devra effectuer chez un psychiatre psychothérapeute

Tr anxieux

Une patiente désespérée de 29 ans se rend à la consultation de son médecin. Elle a beaucoup de mal à quitter sa maison car elle doit contrôler de façon répétitive si la porte de la maison est bien fermée. Sur le plan du diagnostic différentiel laquelle des informations suivantes vous aide **le moins** ?

- A. Anamnèse de pensées obsessionnelles
- B. Anamnèse d'agoraphobie
- ☒ C. Anamnèse de consommation d'alcool et de drogues
- D. Investigation de la présence d'hallucinations auditives
- E. Investigation de la personnalité de la patiente

Tr. anxieux

Une femme de 35 ans s'est rendue plusieurs fois aux urgences suite à l'apparition brusque de dyspnée, de tachycardie, de tremblements et de sudations. Les investigations somatiques n'ont pas mis en évidence d'origine organique. Quel traitement **est le moins** indiqué ?

- A. Psychothérapie
- B. Benzodiazépine
- C. Tricyclique
- D. Inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine
- E. Neuroleptique sédatif

Tr. anxieux

Un homme de 49 ans avec une longue anamnèse de trouble panique chronique et de dépendance à l'alcool et qui est sans-abri insiste pour quitter immédiatement l'hôpital en raison d'obligations familiales et professionnelles pressantes. Quel est l'élément le plus probable que vous allez trouver à l'examen clinique ?

- A. Une agoraphobie
- B. Des symptômes maniaques
- ☒ C. Des hallucinations auditives
- D. Des troubles de la mémoire
- E. Des troubles de la conscience

Tr. anxieux

Parmi les symptômes suivants, quel est le plus spécifique d'un Etat de stress post traumatique (ESPT, PTSD):

- A. Irritabilité
- B. Troubles du sommeil
- C. Conduites d'évitement
- D. Cauchemars en lien avec le traumatisme**
- E. Episodes de dépersonnalisation

Tr. anxieux

Vous recevez à votre consultation de médecine interne générale un jeune homme qui a été impliqué il y a deux mois dans un grave accident de la circulation, au cours duquel sont décédés deux de ses amis proches. Lui-même, assis à l'arrière de la voiture avec la ceinture attachée, s'en sort sans aucune blessure et sans avoir perdu connaissance malgré la violence du choc. Il se plaint de l'apparition progressive de troubles du sommeil, de cauchemars à répétition dans lequel il revit l'accident, de fatigue et d'irritabilité. Par ailleurs il n'ose plus prendre le volant de peur d'avoir un accident. Quelle est la meilleure attitude ?

- A. Le rassurer sur le fait que ces symptômes vont spontanément passer
- B. Lui proposer un rendez-vous dans un mois pour surveiller son évolution
- ☒ C. L'envoyer chez un psychiatre psychothérapeute pour un consilium et une prise en charge spécialisée si nécessaire
- D. Lui prescrire de l'alprazolam (Xanax) comme tranquillisant
- E. Lui prescrire un tranquillisant, l'alprazolam (Xanax) et un antidépresseur, le escitalopram (Ciprallex)

Tr. de la personnalité

Quel est le trouble psychiatrique pour lequel la psychothérapie est le seul traitement curatif:

- A. Trouble dépressif majeur récurrent
- B. Trouble bipolaire de type 2
- C. Trouble obsessionnel compulsif
- ☒ D. Trouble de la personnalité borderline
- E. Trouble de la personnalité antisociale

Tr. de la personnalité

Quel symptôme est plus évocateur d'un trouble borderline que d'un trouble dépressif majeur récurrent :

- A. L'humeur dépressive est stable
- B. Le patient se montre très critique à l'égard de lui-même
- C. Le patient se met fréquemment dans des états de rage contre lui-même ou contre les autres
- D. Le patient a commis des tentatives de suicide
- E. Le patient a perdu du poids

Tr. de la personnalité

Quel est le symptôme qui permet le mieux de faire la différence entre une dépression et des variations de l'humeur liées à un trouble de la personnalité borderline?

- A. Humeur dépressive
- B. Irritabilité
- C. Idées suicidaires
- D. Anhédonie
- ☒ E. Impulsivité

Tr. personnalité

Parmi les symptômes et signes suivants, lequel est le plus spécifique d'un trouble de la personnalité borderline:

- A. Excentricité
- B. Fatigue chronique
- C. Instabilité de l'humeur
- D. Isolement social
- E. Fuite des idées

Tr. de la personnalité

Une jeune patiente de 27 ans, souffrant d'un trouble de la personnalité borderline, que vous suivez depuis longtemps, vous décrit avoir eu la veille pour la première fois des hallucinations visuelles. Laquelle de ces propositions est **fausse**?

- A. Vous pouvez suspecter une prise de substance psycho-active
- B. Vous recherchez une consommation chronique d'alcool et la possibilité d'un sevrage récent.
- ☒ C. Les hallucinations visuelles sont fréquentes dans le diagnostic de trouble de la personnalité borderline en cas de stress aigu
- D. Ces hallucinations visuelles vous inquiètent, et vous réfléchissez à l'organisation d'un éventuel bilan neurologique
- E. Vous effectuez un status psychiatrique et neurologique complet

Tr. de la personnalité

Vous accueillez à votre consultation un patient de 28 ans et de langue maternelle française qui se plaint d'une humeur instable et d'une impulsivité marquée sous la forme de troubles de passages à l'acte violents dans des situations de conflit au travail. Il a de la peine à nouer une relation sentimentale satisfaisante qui dure plus que 6 mois. Parmi les symptômes suivants qu'il présente par ailleurs, lequel fait le plus suspecter un début de schizophrénie plutôt qu'un trouble de la personnalité borderline :

- A. Des sentiments de vide
- B. Une image de lui-même qui oscille entre une assurance excessive et des moments de dévalorisation
- C. Une alternance entre des mouvements de séduction et de méfiance à votre égard
- D. La conviction que son employeur ne lui fait pas confiance et attend le premier prétexte pour le mettre à la porte
- E. L'utilisation récurrentes d'expression incorrectes de la langue française : il parle par exemple de « sphère vicieuse »

Psychothérapies

A propos de psychothérapies, laquelle des affirmations ci-dessous est correcte?

- A. Pour qu'une psychothérapie soit efficace, il faut au minimum une séance par semaine
- B. Il est contre-indiqué de donner des médicaments psychotropes à un patient en psychothérapie, car ils interfèrent de façon néfaste avec le processus de guérison
- C. Une psychothérapie chez des patients atteints de schizophrénie est inutile
- D. Les thérapies systémiques visent à faire prendre conscience aux parents de leur responsabilité dans la survenue de troubles psychiatriques chez leur enfant
- ☒ E. Les thérapies psychodynamiques peuvent être brèves (moins de 15 séances)

Psychothérapies

Sur quel constat sont basées les thérapies cognitivo-comportementales de la dépression ?

- A. Dans les modèles animaux, un paradigme d'impuissance acquise montre des éléments qui rappellent la dépression
- B. Les individus déprimés ont souvent une anamnèse de pertes
- C. Une période de stress précède habituellement les épisodes dépressifs
- D. Un modèle d'agressivité retournée contre soi semble expliquer les symptômes chez beaucoup de patients déprimés
- E. Beaucoup de patients déprimés ont des distorsions négatives de la pensée à propos d'eux-mêmes qui peuvent être modifiées dans le cadre d'un travail thérapeutique

Suicide

A propos du risque suicidaire, **laquelle de ces propositions est-elle juste ?**

- A. Il faut hospitaliser tous les patients qui évoquent des idées suicidaires
- ☒ B. L'existence de tentatives de suicide antérieures qui n'ont pas abouti augmente le risque d'un suicide réussi
- C. Lorsqu'un patient décrit en détail le scénario qu'il a imaginé pour se suicider, on peut considérer que le risque est faible car le patient est capable d'en parler
- D. La grande majorité des patients (>70%) ayant réussi leur suicide présentaient peu auparavant les symptômes caractéristiques du Trouble dépressif majeur
- E. Il vaut mieux évoquer le risque suicidaire avec les proches d'un patient plutôt qu'avec celui-ci, car parler de ce sujet augmente le risque de passage à l'acte

Evaluation du potentiel suicidaire

- **Risque:** facteurs prédisposant sur le plan épidémiologique, augmentant le risque de mourir par suicide
- **Urgence:** imminence de la conduite suicidaire – degré d'élaboration du scénario suicidaire (où, quand, comment, avec quoi)
- **Dangerosité:** létalité et accessibilité du moyen

Risque

- Tentatives précédentes
- Troubles psychiatriques (90%)
- Troubles santé physique (maladie, handicap)
- Crise relationnelle (40% sans emploi)
- Isolement (45% vivent seul)
- Accès aux moyens
- Contagion

Risque

Chez 90% des suicidés (autopsies psychiatriques):

- | | |
|-------------------|-----|
| ■ Dépression | 50% |
| ■ Tr personnalité | 35% |
| ■ Alcoolisme | 30% |
| ■ Schizophrénie | 6% |